

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN LAKTASI & EDUKASI ASI EKSKLUSIF		
	No.Dokumen 922.18/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Manajemen Laktasi adalah tata laksana menyeluruh yang mengintegrasikan upaya promosi, edukasi, bimbingan, dan pemantauan terhadap ibu menyusui sejak masa antenatal hingga pasca-persalinan guna menjamin keberhasilan pemberian ASI. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, tanpa tambahan cairan lain (seperti susu formula, air putih, madu, jeruk) dan tanpa makanan padat, kecuali obat, vitamin, dan mineral atas indikasi medis.		
Tujuan	1. Meningkatkan capaian ASI Eksklusif pada bayi yang dirawat di ruang Perina (sesuai indikator mutu klinis PONEK) 2. Mencegah komplikasi akibat kesalahan pemberian nutrisi (misalnya NEC/ <i>Enterokolitis Nekrotikans</i>) 3. Memberikan dukungan psikologis dan teknis kepada ibu agar tetap memproduksi ASI meskipun terpisah secara fisik dari bayinya		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan PONEK 24 jam		
Prosedur	A. Tahap Persiapan 1. Lakukan 5S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perawat/bidan yang bertugas melakukan asesmen awal terhadap status laktasi ibu (apakah ASI sudah keluar, kondisi puting susu, riwayat menyusui sebelumnya, dan kesiapan psikologis) 3. Lakukan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai : a. Pentingnya kolostrum (ASI hari 1-3) sebagai imunisasi pertama bagi bayi b. Manfaat ASI Eksklusif untuk bayi sakit/prematur yang dirawat di Perina c. Bahaya pemberian susu formula tanpa indikasi medis yang ketat B. Manajemen Edukasi Teknis 1. Teknik Memerah ASI (Manual & Pompa)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN LAKTASI & EDUKASI ASI EKSKLUSIF		
	No.Dokumen 922.18/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3

	a. Ajarkan ibu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memerah b. Demonstrasikan teknik memijat payudara (pijat oksitosin) untuk merangsang refleks pancaran ASI (<i>let-down reflex</i>) c. Ajarkan teknik memerah dengan tangan atau menggunakan pompa ASI elektrik/manual yang steril 2. Penyimpanan ASI Perah (ASIP) a. Edukasikan penggunaan wadah kaca atau plastik khusus (BPA free) yang berlabel nama bayi, tanggal, dan jam perah b. Berikan panduan durasi penyimpanan : Suhu ruang (4 jam), Kulkas bawah/Chiller (4-5 hari), Freezer pintu tunggal (2 minggu), Freezer pintu ganda (3-6 bulan) C. Prosedur Penerimaan dan Pengelolaan ASIP di Ruang Perina 1. Setiap ASIP yang dibawa oleh ibu/keluarga ke ruang Perina wajib diterima oleh perawat jaga 2. <i>Double Check</i> Identitas (Sasaran Keselamatan Pasien): Perawat bersama keluarga melakukan verifikasi identitas pada label botol ASIP, mencocokkannya dengan gelang identitas bayi (Nama Bayi/Nama Ibu, Tanggal Lahir) 3. Simpan ASIP di kulkas khusus penyimpanan obat/nutrisi bayi di ruang Perina berdasarkan metode FIFO (<i>First In, First Out</i>) dan tanggal kedaluwarsa terdekat D. Metode Pemberian ASI pada Bayi Perina 1. Bayi Refleks Hisap Belum Kuat/ Prematur : Berikan ASIP yang telah dihangatkan menggunakan feeding syringe, sendok khusus, atau melalui selang Lambung (OGT/NGT) dengan metode gravitasi. Hindari penggunaan dot untuk mencegah bingung putting 2. Bayi Kondisi Stabil a. Fasilitasi metode Perawatan Metode Kanguru (PMK) jika kondisi bayi memungkinkan b. Bimbing ibu melakukan teknik menyusui langsung (<i>direct breastfeeding</i>) dengan posisi dan pelekatan (<i>latch-on</i>) yang benar (perut bayi menempel perut
--	---

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MANAJEMEN LAKTASI & EDUKASI ASI EKSKLUSIF		
	No.Dokumen 922.18/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	ibu, mulut terbuka lebar, seluruh areola bawah masuk ke mulut bayi) E. Pemantauan dan Evaluasi 1. Pantau volume ASI yang diproduksi ibu setiap hari dan jumlah asupan (intake) yang masuk ke bayi 2. Monitor tanda-tanda kecukupan ASI pada bayi (BAK >6 kali dalam 24 jam setelah hari ke-3, BAB transisi, penurunan berat badan fisiologis tidak melebihi 10%) 3. Dokumentasikan kegiatan edukasi laktasi, jumlah produksi ASIP, dan metode pemberian cairan di Lembar Edukasi Terintegrasi dan Lembar Catatan Keperawatan pasien		
Unit Terkait	<i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i> Perinatologi Instalasi Rawat Inap (IRNA) Anak		